



-NEUROCLÍNICA E NEUROCIRURGIA -PEDIATRIA

Profa. Juliana Fonteles



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



LESÕES NEUROLÓGICAS



AVC-----DCV

TCE

PARKINSON

TRM

DOENÇAS DESMIELINIZANTES

DOENÇAS AUTOIMUNES



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



E SOBRE A PIC O QUE DEVO SABER???





TÔNUS

- Clinicamente se dividem em:

- **Hipertonia:**

1. Espasticidade;
2. Rigidez

- **Hipotonia**





ESPASTICIDADE:

- Comprometimento de certos grupos musculares;
- Maior resposta dos músculos ao estiramento;
- Reflexos tendíneos com maior resposta;
- *Afeta predominantemente os músculos antigravitacionais (flexores dos membros superiores e os extensores dos membros inferiores).*

Os membros superiores tendem a assumir uma postura flexionada e os membros inferiores em extensão.



ESPASTICIDADE

- O estiramento do músculo de um paciente portador de espasticidade resulta em contração reflexa muito intensa e *quanto mais rápido o fisioterapeuta movimentar um membro espástico, maior será o aumento do tônus muscular;*
- Isso acontece por um aumento no ganho do reflexo miotático e da redução do seu limiar;



ESPASTICIDADE

- A hipertonia espástica é uma característica da síndrome do neurônio motor superior.
- Ocorre alterações dos reflexos neural e miotático
- Alterações mecânicas
- Atrofia e desuso
- Redução do numero de sarcômeros
- Aumento de colágeno
- Redução das fibras musculares do tipo II;
- A resistencia aumenta no inicio e logo diminui=
sinal de canivete.

***** AUMENTO DA RIGIDEZ PASSIVA*****





RIGIDEZ

- I. É conhecida clinicamente como uma maior resistência a movimentos passivos mais ou menos lentos.
- II. Está presente nos grupos musculares tanto extensores como flexores.
- III. Quando o examinador estende ou flexiona uma articulação o membro apresenta uma rigidez **em cano de chumbo**= rigidez sentida em todo o movimento.



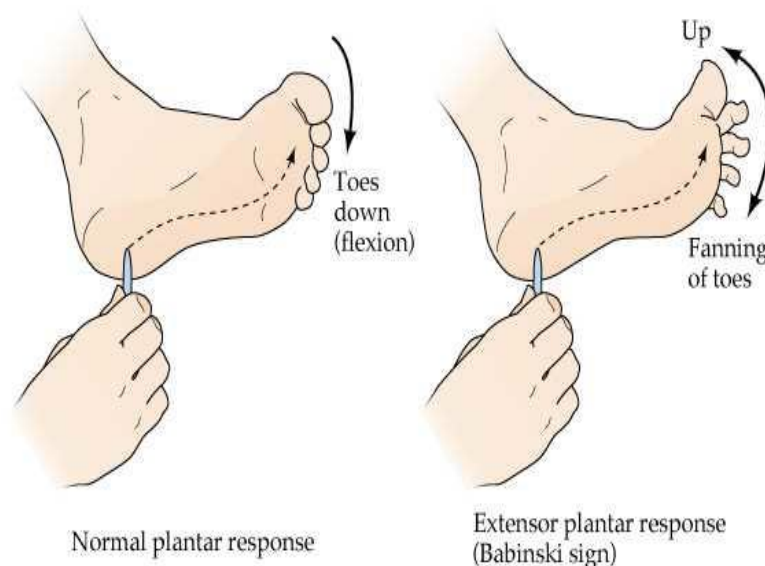
BIZU!!!!

- Muitos pacientes com rigidez apresentam um tremor adicional que caracteriza um = distúrbio extrapiramidal= **sinal da roda denteada.**
- ***Os movimentos impostos aos pacientes devem ser realizados de forma lenta.***
- ***É característico das síndromes extrapiramidais.***

SÍNDROME DO NEURÔNIO MOTOR SUPERIOR



- Fraqueza ou paralisia (paresia/plegia)
- Hipertonia
- Espasticidade
- Hiperreflexia
- Sinal de Babinski
- Sinal de Hoffmann
- Clônus



Os axônios dos NMS, formam os tratos corticoespinhais e corticonuclear. Seus corpos celulares se localizam principalmente no córtex motor primário.

SÍNDROME DO NEURÔNIO MOTOR INFERIOR



- Fraqueza ou paralisia
- Atrofia
- Fasciculações (degeneração do 2º neurônio)
- Hipotonia (flacidez)
- Hiporreflexia ou arreflexia

Os NMI possuem seus corpos celulares nos cornos anteriores da medula espinhal e tronco encefálico. Eles formam os axônios motores longos que suprem os músculos do corpo





MARCHAS PATOLÓGICAS

- Helicoidal, ceifante ou do hemiplégico;
- Anserina ou de pato;
- Parkisoniana;
- Taloneante ou tabética;
- Vestibular ou em estrela;
- Escavante
- Claudicante;
- Em tesoura;



PARALISIA CEREBRAL

• Diplegia/ diparesias :

- Todo o corpo é afetado, mais os MMII são mais afetados que os MMSS.
- Geralmente possuem um bom controle de cabeça
- A fala geralmente não é afetada
- Maior probabilidade de pertencerem ao grupo espástico
- O estrabismo está presente em um certo número de cças.

Quadriplegia ou tetraplegia (tetraparesias):

- Todo o corpo é afetado
- Os MMSS e o tronco são mais afetados que os MMII.
- Em alguns casos de quadriplegia espástica os MMII podem estar igualmente comprometidos como MMSS e tronco;
- Existe diferença no comprometimento, o que leva a uma assimetria da postura e movimento.
- Déficit de controle da cabeça, da fala e da coordenação ocular.



Hemiplegia/ hemiparesias:

- Somente um dos lados do corpo é afetado;
- Em geral são do tipo espástica.

• Monoplegia/monoparesia:

- Somente um braço ou uma perna é afetada;
- São raras e podem evoluir para hemiparesias;

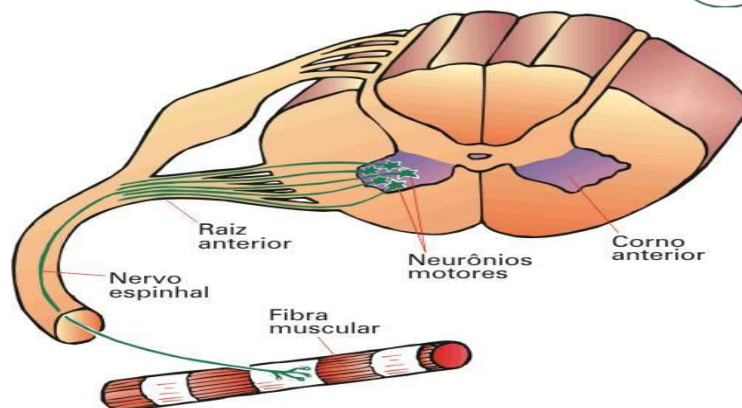
SÍNDROME DE DOWN



- **Resulta em algumas alterações fisiopatológicas que levam a incapacidades:**
- Neuromusculares
- Déficits sensoriais
- Alterações cardiopulmonares
- Atraso no desenvolvimento motor
- Intelectual

- **Características clínicas:**
- Hipotonia
- Frouxidão ligamentar
- Prega simiesca
- Língua protusa
- Dedos curtos
- Tendência a hiporreflexia

A.M.E



- É uma doença das células do corno anterior da medula, que leva a :
- Fraqueza e atrofia muscular simétrica
- Prejuízo da motricidade como segurar a cabeça, sentar e andar
- Tônus muscular diminuído,
- Diminuição dos reflexos tendinosos,
- Fasciculações (pequenas contrações)
- Deformidades estruturais



TIPOS DE AME

1. Tipo I ou AME progressiva ou doença de Werdnig-Hoffmann
2. Tipo II ou AME intermediária
3. Tipo III ou AME juvenil ou doença de Kugelberg-Welander
4. Tipo IV ou AME forma adulta.